



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS



PENGENALAN PERUBAHAN FISIOLOGI DAN TANDA BAHAYA PADA IBU HAMIL DAN IBU NIFAS

Tim Penyusun:

Umaroh, S.KM., S.Tr.Keb., M.Kes.

Ulfah Musdalifah, S.Kep., Ns., S.Tr.Keb., M.Kes.

Dhita Aulia Oktaviani, S.SiT., M.Keb.

Penyunting:

Hariyanti, S.Sos, SS.

Penerbit:

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang



BUKU PANDUAN
Pengenalan Perubahan Fisiologi dan Tanda
Bahaya pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas

Tim Penyusun:

Umaroh, S.KM., S.Tr.Keb., M.Kes.

Ulfah Musdalifah, S.Kep., Ns., S.Tr.Keb., M.Kes.

Dhita Aulia Oktaviani, S.SiT., M.Keb.

Penyunting

Hariyanti, S.Sos, SS.

Penerbit:

PoltekNIK Kesehatan KEMENKES Semarang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Penting Diketahui!

Pembajakan Buku adalah Kriminal!

Anda jangan menggunakan buku bajakan, demi menghargai jerih payah para pengarang yang notabene adalah para guru.

BUKU PANDUAN

PENGENALAN PERUBAHAN FISILOGI DAN TANDA BAHAYA PADA IBU HAMIL DAN IBU NIFAS

Tim Penyusun

Umaroh, S.KM., S.Tr.Keb., M.Kes.
Ulfa Musdalifah, S.Kep., Ns., S.Tr.Keb., M.Kes.
Dhita Aulia Oktaviani, S.Sti., M.Keb.

Penyunting

Harriyanti, S.Sos, SS.

Edisi I, Cetakan Pertama 2020

Diterbitkan oleh :

PoltekNIK Kesehatan Kemenkes Semarang
Telp: 0247477208
perpustakaanpoltekkessmg@yahoo.com
Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Ke. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
50268

ISBN: 978-623-6730-45-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan
Menterjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, sehingga buku panduan pengenalan perubahan fisiologi dan Tanda bahaya pada kehamilan dan Nifas ini dapat tersusun. Buku Panduan ini dapat digunakan oleh ibu hamil, ibu nifas, kader kesehatan dan masyarakat dalam mengenali perubahan kehamilan dan deteksi dini komplikasi kehamilan dan nifas.

Penulis berharap dengan membaca buku ini maka ibu hamil, nifas, kader kesehatan dan masyarakat secara umum akan dapat mengenali perubahan dan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil, nifas sehingga segera mendapat pemanganan secara tepat. Buku ini mengkaji beberapa hal antara lain perubahan kehamilan, Tanda bahaya kehamilan, perubahan masa nifas dan tanda bahaya masa nifas

Semoga buku ini dapat menambah ilmu dan wawasan ibu hamil nifas dan kader kesehatan serta masyarakat secara luas. Demi perbaikan buku ini kami berharap masukan dan saran

Semarang, November 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Hak Cipta	2
Halaman Verso	3
Kata Pengantar	4
POKOK BAHASAN I Perubahan Fisiologi Masa Hamil.....	6
POKOK BAHASAN II Perubahan Fisiologi Masa Nifas.....	17
POKOK BAHASAN III ASI Eksklusif.....	20
TOPIK BAHASAN IV Tanda Bahaya Kehamilan	27
TOPIK BAHASAN V Tanda Bahaya Masa Nifas.....	30

POKOK BAHASAN I

PERUBAHAN FISILOGI KEHAMILAN

Tujuan Pembelajaran :

Mampu memahami definisi kehamilan, perubahan fisik dan psikologi yang terjadi saat kehamilan, komplikasi dan faktor resiko kehamilan.

Apa Kamu tahu apa itu Kehamilan?



Menurut Departemen Kesehatan RI, 2007, kehamilan adalah masa dimulai saat konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal 280 hari (40 minggu / 9 bulan 7 hari) di hitung dari triwulan/ trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan/ trimester ke-2 dari bulan ke- 4 sampai 6 bulan, triwulan/ trimester ke-3 dari bulan ke-7 sampai ke-9.

Sumber : <https://www.alodokter.com/bunda-yuk-kenali-kehamilan-geniatri-dan-risikonya>.

Apakah Kamu tahu Perubahan Fisik pada Ibu Hamil?



Sumber : <https://ibu-hamil.id/perubahan-perubahan-yang-terjadi-pada-saat-kehamilan/perubahan-pada-ibu-hamil/>

Sistem	Organ	Perubahan yang Terjadi
Reproduksi	Rahim	- Ukuran pada kehamilan cukup bulan: 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. - Berat : Berat rahim naik secara luar biasa, dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan (40 pekan). - Posisi rahim pada permulaan kehamilan dalam letak condong ke depan atau ke belakang - Pertumbuhan rahim tidak sama kesemua arah, tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat didaerah ari – ari menempel, sehingga rahim bentuknya tidak sama yg disebut Tanda Piskacek. - Ismus rahim mengadakan hipertropi dan bertambah panjang, sehingga teraba lebih lunak (soft) disebut tanda Asuhan Kehamilan Normal hegar. Pada kehamilan 5 bulan rahim teraba seperti berisi cairan air ketuban dinding rahim teraba tipis
	Leher rahim	- Pembuluh darah bertambah banyak sehingga menjadi lebih lunak. (soft) disebut tanda goodell. - Kelenjar endoservikal membesar dan mengeluarkan banyak cairan

	mukus, karena bertambahnya pembuluh darah dan melebar, warnanya menjadi livid, ini disebut tanda Chadwick.
Jalan lahir	Akibat peningkatan pembuluh darah jalan lahir dan lubang kelihatan lebih merah atau kebiru-biruan. Warna livid pada vagina dan leher rahim disebut tanda Chadwick.
Dinding perut (abdominal wall)	Pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan robeknya serabut elastik dibawah kulit, maka timbulah striae gravidium. Kulit perut pada linea alba bertambah warna gelapnya disebut linea nigra.
Payudara	• Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan pemberian ASI pada laktasi. • Hormon yang berpengaruh pada proses laktasi : Estrogen, Progesteron, Somatomotropin, PIH. • Penampakan payudara sebagai berikut: ✓ Payudara menjadi lebih besar ✓ Areola payudara menjadi lebih besar

	✓ Pengeluaran ASI belum berlangsung karena prolaktin belum berfungsi karena hambatan dari PIH untuk Asuhan Kehamilan Normal mengeluarkan ASI. ✓ Glandula montgomery makin tampak, puting susu semakin menonjol, ✓ Setelah persalinan, hambatan prolaktin tidak ada sehingga pembuatan ASI dapat berlangsung.
Lainnya	Peredaran Darah • Selama kehamilan sirkulasi darah ibu dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yg membesar dgn pembuluh2 darah yang membesar pula, payudara dan alat2 lain yg berfungsi berlebihan selama kehamilan. • Selama kehamilan volume darah ibu semakin meningkat secara fisiologi dengan adanya pencairan (hemodilusi). • Volume darah akan bertambah besar sekitar 25% dgn puncak kehamilan 32 minggu. • Hemodilusi menyebabkan anemia fisiologi dalam kehamilan. • Kadar Hb ibu hamil

	✓ Hb 11 gr% = tidak anemia ✓ 9 – 10 gr% = anemia ringan ✓ 7 – 8 gr% = anemia sedang ✓ < 7 gr% = anemia berat
Sistem pernafasan	• Perubahan sistem pernafasan juga dapat berubah untuk dapat memenuhi kebutuhan O₂. • Terdapat desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada 32 minggu. • Ibu hamil bernafas 20-25% lebih dalam dari biasanya.
Sistem pencernaan	• Karena pengaruh estrogen, pengeluaran asam lambung meningkat menyebabkan : ✓ Pengeluaran air liur berlebihan (hipersalivasi) ✓ Daerah lambung terasa panas ✓ Terasa mual, pusing terutama dipagi hari (morning sickness) ✓ Muntah (emesis gravidarum) • Progesteron menimbulkan gerakan usus (peristaltik) semakin berkurang sehingga menyebabkan obstipasi
Perubahan Tulang dan Gigi	• Persendian panggul terasa agak longgar, karena ligamen melunak

	juga terjadi sedikit pelebaran pada rongga persendian. • Apabila pemberian makan tidak memenuhi kebutuhan kalsium janin, kalsium internal pada tulang-tulang panjang akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan ini.
Saluran Kencing	• Karena pengaruh desakan hamil muda dan turunnya kepala bayi pada hamil tua terjadi gangguan miksi dalam bentuk sering kencing, desakan tersebut menyebabkan kandung kencing cepat penuh. • Persediaan air seni bertambah 69-70%.
Perubahan pada kulit	• Terjadi Hiperpigmentasi (kulit menjadi lebih gelap) yang disebabkan oleh Hormon MSH : ✓ Muka : disebut masker kehamilan (cloasma gravidarum) ✓ Payudara : puting susu dan areola payudara ✓ Perut : linea nigra striae (garis putih pada kulit) ✓ Vulva
Metabolisme (proses dalam tubuh)	• Meningkatkan proses dalam tubuh Metabolisme basal naik sebesar 15% sampai 20% dari semula, terutama pada trisemester I.

- Keseimbangan asam basa mengalami penurunan disebabkan hemodilusi darah dan kebutuhan mineral yang diperlukan janin.
- Kebutuhan protein wanita hamil makin tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Perkembangan organ kehamilan dan persiapan laktasi. Dalam makanan diperlukan protein tinggi sekitar $\frac{1}{2}$ gr/kg BB atau sebutir telur ayam sehari.

Apa yang Kamu Ketahui Tentang Perubahan Psikologis (emosi) pada Ibu Hamil?



Sumber : <https://www.popmama.com/pregnancy/second-trimester/annas/perubahan-fisiologis-pada-ibu-hamil>

Waktu	Perubahan yang Terjadi
Trimester I (3 Bulan Pertama Kehamilan)	• Pada trimester I atau bulan-bulan pertama ibu akan merasa tidak berdaya dan merasa minder karena ibu merasakan perubahan pada dirinya. • Segera setelah konsepsi kadar hormon estrogen dan progesteron meningkat, menyebabkan mual

dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan pembesaran payudara

- Mencari tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa dirinya hamil
- Hasrat untuk melakukan hubungan seks pada trimester pertama berbeda2, kebanyakan wanita hamil mengalami penurunan pada periode ini

Trimester II (3 bulan kedua Kehamilan)

- Pada trimester II ibu merasakan adanya perubahan pada bentuk tubuh yang semakin membesar sehingga ibu merasa tidak menarik lagi dan merasa suami tidak memperhatikan lagi.
- Ibu merasakan lebih tenang dibandingkan dengan trimester I karena nafsu makan sudah mulai timbul dan tidak mengalami mual muntah sehingga ibu lebih bersemangat.
- Pada TM II biasanya ibu lebih bisa menyesuaikan diri dengan kehamilan selama trimester ini dan ibu mulai merasakan gerakan janinnya pertama kali.

Trimester III (3 bulan Ketiga Kehamilan)

- Trimester III seringkali disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya.
- Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala akan terjadinya persalinan.
- Rasa tidak nyaman timbul karena ibu merasa dirinya aneh dan jelek. Disamping itu ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dengan

bayinya dan kehilangan perhatian yang khusus diterima selama hamil. Pada trimester inilah ibu membutuhkan kesenangan dari suami dan keluarga.

- Pada TM III ibu merasa tidak nyaman dan depresi karena janin membesar dan perut ibu juga, melahirkan, sebagian besar wanita mengalami klimaks kegembiraan emosi karena kelahiran bayi.

Apa saja Komplikasi pada Ibu Hamil?



Sumber : <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/komplikasi-kehamilan-penyakit-ibu-hamil/>

Sebagian besar kematian ibu dapat di cegah apabila mendapat penanganan yang adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor waktu dan transportasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam merujuk kasus risiko tinggi. Oleh karenanya deteksi dini faktor risiko pada ibu merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu.

Komplikasi pada ibu hamil antara lain :

1. Ketuban pecah dini.
2. Perdarahan pervaginam : Perdarahan pada ante partum yaitu keguguran, placenta previa, solutio placenta.
3. Hipertensi dalam kehamilan (HDK): tekanan darah tinggi (sistolik >140 mmHg, diastolik > 90 mmHg), dengan atau tanpa edema pretibial.

4. Ancaman persalinan prematur.
5. Infeksi berat dalam kehamilan: demam berdarah, tifus abdominalis, sepsis.
6. Preeklampsia

Apa saja Faktor Resiko Pada Ibu Hamil?

Sumber : <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2959469/hamil-ke-20-pa-atri-mi-kehabisan-ide-nama-anak>

Menurut Direktorat Bina Kesehatan Ibu (2009), faktor risiko pada ibu hamil adalah:

1. Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
2. Anak lebih dari 4.
3. Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun.
4. Kurang Energi Kronis (KEK) dengan lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm, atau penambahan berat badan < 9 kg selama masa kehamilan.
5. Anemia dengan haemoglobin < 11 g/dl.
6. Tinggi badan < 145 cm, atau dengan kelainan bentuk panggul dan tulang belakang
7. Riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya atau sebelum kehamilan ini.
8. Sedang/pernah menderita penyakit kronis, antara lain : tuberkulosis, kelainan jantung, ginjal, hati, psikosis, kelainan endokrin (Diabetes melitus, Sistemik lupus Eritematosus,dll), tumor dan keganasan.
9. Riwayat kehamilan buruk : keguguran berulang, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa, ketuban pecah dini, bayi dengan cacat kongenital.



10. Riwayat persalinan dengan komplikasi : persalinan dengan sesio sesarea, ekstraksi vakum/forceps.

11. Riwayat nifas dengan komplikasi : perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, psikosis post partum (post partum blues).
12. Riwayat keluarga menderita penyakit kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital.
13. Kelainan jumlah janin : kehamilan ganda, janin dempet, monster.
14. Kelainan besar janin : pertumbuhan janin terhambat, janin besar.
15. Kelainan letak dan posisi janin : lintang/oblique, sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.

Sumber Pustaka:

- Depkes RI. 2007. *Pedoman Pelayanan Antenatal*. Jakarta: Depkes RI
- Direktorat Bina Kesehatan Ibu. 2009. *Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Ibu
- Purnawan. 2015. *Perubahan Fisiologis dan Psikologis pada Wanita Hamil*. <http://repository.ump.ac.id/934/5/Diane%20Prisla%20Purnawan%20BAB%2011.pdf>. Diakses pada 23 Februari 2020.

POKOK BAHASAN II

PERUBAHAN FISILOGI MASA NIFAS

Tujuan Pembelajaran

Mengetahui pengertian nifas, tahapan masa nifas, perawatan pada masa nifas, dan komplikasi masa nifas.

Apa yang Kamu Ketahui Tentang Masa Nifas?



Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahir placenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu.

Puerperium yaitu dari kuta puer yang artinya bayi dan Parous melahirkan. Jadi Puerperium berarti masa setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil (Susilo, Feti, 2016).

Apa Saja Tahapan pada Masa Nifas?

Masa nifas dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Puerperium Dini Yaitu kepulihan dimana ibu diperbolehkan dan berjalan serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainnya (40 hari).
2. Puerperium Intermediate Yaitu suatu kepulihan menyeluruh alat-alat genetelia yang lamanya sekitar 6- 8 minggu
3. Remote Puerperium Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi (Susilo, Feti, 2016)

Apa Saja Perawatan Pada Masa Nifas?



Post partum atau nifas merupakan keadaan dimana masa pemulihan alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil. Dalam masa nifas perlu melakukan perawatan untuk membantu proses involusi misalnya mobilisasi, diet, miksi, defekasi, laktasi, perawatan payudara dan dan perawatan perineum.

Proses persalinan hampir 90% yang mengalami robekan perineum, baik dengan atau tanpa episiotomi. Luka perineum didefinisikan sebagai adanya robekan pada jalan rahim maupun karena episiotomi pada saat melahirkan janin.

Apa saja Komplikasi yang dapat Terjadi pada Masa Nifas?



Sumber : <http://budanmama.com/kesehatan/kesehatan-wanita/11-masalah-pada-masa-nifas/>

Komplikasi yang dapat terjadi pada mas nifas adalah perdarahan, puvangam, infeksi nifas, sakit kepala, nyeri epigastrik, pengalihan kabur, pembengkakan di wajah dan ekstremitas, demam, muntah, rasa sakit waktu berkamih, payudara yang berubah menjadi merah, panas dan sakit, kehilangan nafsu makan dalam waktu

lama, merasa sedih dan merasa tidak mampu mengasuh sendiri bayinya dan dirinya (Manuaba, 1998).

Sumber Pustaka:

Manuaba, Ayu Ida C.H Bagus, Ida G.F.Manuaba, Ida Bagus Manuaba .2008. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC.

Rini, Susilo & Kumala, Feti. (2016). *Panduan Asuhan Nifas & Evidence Based Practice*. Yogyakarta: Deepublish.

POKOK BAHASAN III ASI EKSKLUSIF

Tujuan Pembelajaran : Mengetahui Pengertian ASI Eksklusif, manfaat atau keuntungan memberikan ASI Eksklusif.

Apa yang diketahui dari ASI Eksklusif?



World Health Organization (WHO), merekomendasikan bayi mendapat ASI eksklusif, yaitu memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur enam bulan, kecuali

obat dan vitamin, namun bukan berarti setelah pemberian ASI eksklusif selesai pemberian ASI dihentikan, akan tetapi ASI tetap diberikan sampai bayi berusia dua tahun. (WHO, 2011)

Apa Saja Manfaat dari pemberian ASI Eksklusif?

A. Bagi Bayi



Sumber: <https://kaitlynnamberly.wordpress.com/2016/02/17/asi-eksklusif-part-3/>

1. Mengandung komposisi yang tepat

ASI Berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi yaitu terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama (Kristiyansari, 2009).

2. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi

Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapat ASI Eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang-kejang sel-sel saraf otak (Kristiyansari, 2009).

3. Mengandung zat protektif

Bayi yang mendapat ASI lebih jarang menderita penyakit karena adanya zat protektif dalam ASI (Sunardi, 2008).

4. Antibodi

Secara elektroforetik, kromatografik dan radio immunoassay terbukti bahwa ASI terutama kolostrum mengandung imunoglobulin yaitu IgA sekretorik (SigA), IgE, IgM, dan IgG. Antibodi dalam ASI dapat bertahan dalam saluran pencernaan bayi karena tahan terhadap asam dan enzim proteolitik saluran pencernaan dan membuat lapisan pada mukosanya sehingga mencegah bakteri patogen dan enterovirus masuk kedalam mukosa usus.

5. Imunitas seluler

ASI yang mengandung sel-sel, sebagian besar (90%) sel tersebut berupa makrofag yang berfungsi membunuh dan memfagositosis mikroorganisme, membentuk C3 dan C4, lizozim dan lactoferin. Sisanya (10%) terdiri dari limfosit B dan T. Angka leukosit pada kolostrum kira-kira 5000/ml setara dengan angka leukosit darah tepi tetapi komposisinya berbeda dengan darah tepi, karena hampir semuanya berupa polimorfonuklear dan mononuklear.

6. Tidak menimbulkan alergi

Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivitas sistem ini dan dapat menimbulkan

alergi. ASI tidak menimbulkan efek ini. Pemberian protein asing yang ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi kemungkinan alergi (Suradi, 2004).

7. Mempunyai efek psikologis yang menguntungkan

Waktu menyusui kulit bayi akan menempel pada kulit ibu. Kontak kulit yang dini ini akan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan bayi kelak. Walaupun seorang ibu dapat memberikan kasih sayang yang besar dengan memberikan susu formula tetapi menyusui sendiri akan memberikan efek psikologis yang besar. Dengan foto infra merah, payudara ibu menyusui lebih hangat dibanding payudara ibu yang tidak menyusui (Kristiyansari, 2009).

Interaksi yang timbul waktu menyusui antara ibu dan bayi akan menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan aman ini penting untuk menimbulkan dasar kepercayaan pada bayi (basic sense of trust) yaitu dengan mulai dapat mempercayai orang lain (ibu) maka akan timbul rasa percaya pada diri sendiri (Suradi, 2004).

8. Menyebabkan pertumbuhan yang baik

Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal baik dan mengurangi kemungkinan obesitas. Ibu-ibu yang diberi penyuluhan tentang ASI dan laktasi, turunnya berat badan bayi (pada minggu pertama kelahiran) tidak sebanyak ibu-ibu yang tidak diberi penyuluhan. Alasannya ialah bahwa kelompok ibu-ibu tersebut segera memberikan ASInya setelah melahirkan. Frekuensi menyusui yang sering (tidak dibatasi) juga dibuktikan bermanfaat karena volume ASI yang dihasilkan lebih banyak sehingga penurunan berat badan bayi hanya sedikit (Suradi, 2004).

B. Bagi Ibu



Sumber: <https://kailymambersly.wordpress.com/2016/02/17/asi-eksklusif-part-3/>

1. Aspek kesehatan ibu

Isapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan pasca persalinan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Kejadian karsinoma mammae pada ibu menyusui lebih rendah dibanding yang tidak menyusui (Kristiyansari, 2009).

2. Aspek keluarga berencana

Menyusui secara murni Eksklusif dapat menjarangkan kehamilan. Ditemukan rata-rata ibu yang menyusui adalah 24 bulan sedangkan yang tidak menyusui 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja untuk menekan hormon ovulasi sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan. Ibu yang sering hamil kecuali menjadi beban sendiri juga merupakan risiko tersendiri bagi ibu untuk mendapatkan penyakit seperti anemia, risiko kesakitan dan kematian akibat persalinan (Suryoprajogo, 2009).

3. Aspek psikologis

Keuntungan menyusui bukan hanya bermanfaat bagi bayi tetapi juga untuk ibu. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia (Suradi, 2004).

C. Bagi Keluarga

1. Aspek ekonomi

ASI tidak perlu dibeli sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain. Kecuali itu, penghematan juga disebabkan karena bayi yang mendapatkan ASI lebih jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat (Sunardi, 2008).

2. Aspek kemudahan

Menyusui sangat praktis karena dapat diberikan dimana saja dan kapan saja. Keluarga tidak repot untuk menyiapkan air masak, botol dan dot yang harus selalu dibersihkan, orang tidak perlu minta pertolongan orang lain (Arif, 2009).

D. Bagi Negara

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi

Adanya faktor protektif dan nutrisi yang sesuai dalam ASI menjamin status gizi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun. Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, misalnya diare, otitis media dan infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah (Kristiyansari, 2009).

2. Mengurangi subsidi kesehatan

Subsidi untuk rumah sakit berkurang karena rawat gabung akan memperpendek lama rawat ibu dan bayi, mengurangi komplikasi persalinan dan infeksi nosokomial, serta mengurangi biaya yang diperlukan untuk perawatan sakit. Anak yang diberi ASI lebih jarang dirawat di rumah sakit dibanding anak yang mendapat susu formula (Suradi, 2004).

3. Menghemat devisa untuk membeli susu formula

ASI dapat dianggap sebagai kekayaan nasional. Jika semua ibu menyusui Eksklusif selama 6 bulan berapa banyak devisa yang dapat dihemat oleh negara yang sebelumnya dipakai untuk membeli susu formula (Sunar, 2009).

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Anak yang mendapat ASI dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kualitas generasi penerus bangsa akan terjamin.

Apa Saja Tanda-Tanda Bahwa Bayi Cukup ASI?



Sumber: <https://modo.co.id/tanda-bayi-cukup-asi/>

Tanda-tanda bahwa bayi cukup mendapatkan ASI:

1. Bayi menyusui 8-12 kali sehari, dengan perlekatan yang benar pada setiap payudara dan menghisap secara teratur selama minimal 10 menit pada setiap payudara.
2. Frekuensi buang air besar (BAB) bayi > 4 kali sehari dengan volume paling tidak 1 sendok makan, tidak hanya berupa noda membekas pada popok bayi, pada bayi berusia 4 hari sampai 4 minggu. Sering ditemukan bayi yang BAB setiap kali setelah menyusui, hal ini merupakan hal yang normal.
3. Feses berwarna kekuningan dengan butiran-butiran berwarna putih susu diantaranya atau disebut *seedy milk* setelah bayi berumur 4-5 hari. Apabila setelah bayi berumur 5 hari feses bayi masih berupa mekonium atau transisi antara hijau kecoklatan, mungkin ini tanda bayi kurang mendapatkan ASI.
4. Terdapat kenaikan berat badan rata-rata 500 gram perbulan.
5. Puting payudara akan terasa sakit pada hari-hari pertama menyusui. Apabila sakit ini bertambah dan menetap setelah 5-7 hari, lebih-lebih apabila disertai dengan lecet hal ini merupakan tanda bahwa bayi tidak melekat dengan baik saat menyusui. Apabila tidak segera ditangani dengan membetulkan posisi dan

perlekatan bayi maka hal ini akan menurunkan produksi ASI.

6. Bayi tampak sehat, warna kulit dan turgor baik, anak cukup aktif. (Siregar, 2004: 7)

Terdapat dua tanda yang dapat dipercaya bayi tidak mendapat cukup ASI, yaitu pertambahan berat badan bayi kurang (kurang dari 500 gram per bulan, atau kurang dari berat lahir setelah dua minggu, atau pada bayi ≥ 2 minggu penurunan BBnya $\geq 10\%$ berat lahir) dan bayi mengeluarkan air seni pekat dalam jumlah sedikit (BAK kurang dari 6 kali sehari, warnanya kuning dan baunya tajam). Selama enam bulan pertama, bayi sebaiknya bertambah berat paling sedikit 500 gram setiap bulan, atau 125 gram setiap minggu. Bila bayi bertambah berat kurang dari 500 gram sebulan, berarti pertambahan beratnya tidak cukup (Departemen Kesehatan RI, 2007).

Sumber Pustaka:

- Arif, N. 2009. *Panduan Ibu cerdas ASI dan Tumbuh kembang*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Depkes RI (2007). *Pelatihan Konseling Menyusui Panduan Pelatih*. Jakarta: Depkes RI direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat.
- Kristiyansari, W. 2009. *ASI, Menyusui dan Sadari*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Siregar, Arifin. (2004). *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (jurnal). Medan. Sumatera Utara: Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat FKM USU. <http://library.usu.ac.id/download/fkm.arifin.pdf>.
- Sunar, Dwi Prasctono. 2009. *Buku Pintar ASI Eksklusif, Pengenalan Praktek dan Kemfaatannya*. Yogyakarta: Penerit Diva Press
- Suryoprajogo, N. 2009. *Keajaiban Menyusui*. Yogyakarta: Key Word.

TOPIK BAHASAN IV TANDA BAHAYA KEHAMILAN

Tujuan Pembelajaran: Dapat melakukan deteksi dini kehamilan resiko tinggi dan dapat melakukan penanganan dengan segera untuk mendapatkan pertolongan segera.

Apa Saja Tanda Bahaya Pada Ibu Hamil?

No	Gambar	Tanda Bahaya	Penjelasan
1		Ibu hamil yang muntah terus dan tidak mau makan.	Mual muntah yang berlebih dan mengganggu aktivitas akan membahayakan ibu dan janinnya. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.
2		Demam melebihi 38 °C atau lebih tinggi.	Demam dapat menunjukkan bahwa ibu terkena infeksi atau terjangkit penyakit seperti malaria atau demam berdarah.
3		Pandangan kabur, sakit kepala, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, tekanan darah tinggi dan disertai kejang.	Gejala tersebut menunjukkan ibu mengalami Preeklamsia/Eklamsia. Ibu dengan gejala tersebut harus seger

	Sumber: Buku KIA		dibawa ke fasilitas kesehatan.
4	 Sumber: Buku KIA	Ibu hamil dengan usia kandungan lebih dari 4 bulan tidak merasakan gerakan janin atau janin dirasa kurang bergerak dibanding sebelumnya.	Kurang aktifnya pergerakan janin menunjukkan adanya gangguan pada janin, jadi normalnya bergerak 10x dalam 12 jam. Jika janin dirasa kurang aktif bergerak segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.
5	 Sumber: Buku KIA	Mengeluarkan darah pada saat hamil baik hamil muda maupun tua.	Keluarnya darah dari jalan lahir menunjukkan suatu kegawatdaruratan dan harus segera ditangani penyebabnya. Pada hamil muda keluarnya darah bisa menjadi tanda terjadinya keguguran. Sedangkan pada hamil tua menjadi tanda adanya gangguan pada plasenta, antara plasenta yang lepas atau plasenta yang

			letaknya dekat dengan jalan lahir.
6	 Sumber: Buku KIA	Air ketuban keluar sebelum waktunya.	Keluarnya air ketuban sebelum waktunya sangatlah berbahaya. Selain dapat menyebabkan infeksi pada janin, kekurangan air ketuban dapat menyebabkan sulitnya janin lahir secara normal.

TOPIK BAHASAN IV
TANDA BAHAYA NIFAS

Tujuan Pembelajaran: Dapat melakukan deteksi dini kehamilan resiko tinggi dan dapat melakukan penanganan dengan segera untuk mendapatkan pertolongan segera.

Apa Saja Tanda Bahaya Pada Ibu Nifas?

No	Gambar	Tanda Bahaya	Penjelasan
1	 Sumber: Buku KIA	Nyeri perut hebat dan perdarahan yang berlebihan lewat jalan lahir.	Nyeri perut hebat disertai perdarahan yang berlebihan lewat jalan lahir pada ibu nifas secara terus menerus menunjukkan adanya gangguan pada sistem reproduksi dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
2	 Sumber: Buku KIA	Keluar cairan berbau dari jalan lahir.	Keluarnya cairan berbau menunjukkan adanya infeksi.

3	 Sumber: Buku KIA	Pandangan kabur, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit hebat kepala disertai kejang.	Tanda-tanda tersebut menunjukkan gejala Preeklamsia/eklamsi. Ibu harus segera dilarikan ke fasilitas kesehatan.
4	 Sumber: Buku KIA	Demam lebih dari 2 hari.	Pada kasus ini ibu harus segera dilarikan ke fasilitas kesehatan karena ibu mengalami infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh atau biasa disebut dengan sepsis.
5	 Sumber: Buku KIA	Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit atau nyeri.	Kasus ini terjadi pada ibu yang tidak dapat mengeluarkan asinya, jika terus dibiarkan akan muncul gumpalan.
6	 Sumber: Buku KIA	Ibu tampak sedih, murung, menangis, nafsu makan turun, tidak mau mengurus bayinya.	Jika ibu mengalami salah satu dari gejala tersebut maka ibu harus segera mendapatkan konsultasi atau dukungan dari

			keluarga agar tidak bertambah parah.
--	--	--	--------------------------------------

KUISIONER DETEKSI DINI PADA KEHAMILAN, NIFAS, DAN PENGERTIAN ASI EKSKLUSIF

Nama :

Umur :

Petunjuk pengisian jawaban pertanyaan berikut dengan menggunakan tanda silang (X) memilih salah satu jawaban yang menurut ibu benar.

No	Pertanyaan kehamilan resiko tinggi	Jawaban	
1	Kehamilan usia kurang dari 20 tahun tidak bahaya	B	S
2	Kehamilan usia lebih dari 35 tahun tidak bahaya	B	S
3	Ibu yang sering hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun merupakan resiko tinggi kehamilan	B	S
4	Mengeluarkan darah saat hamil merupakan tanda bahaya pada kehamilan	B	S
5	Ibu hamil yang muka, tangan dan kaki bengkak merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
6	Sakit kepala hebat merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
7	Nyeri perut hebat merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
8	Keluarnya cairan dari jalan lahir yang berbau khas merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
9	Pandangan kabur merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
10	Pada ibu hamil dengan usia kandungan lebih dari 4 bulan tidak merasakan gerakan janin merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S

No	Pertanyaan Nifas resiko tinggi	Jawaban	
1	Ibu nifas yang mengalami demam tinggi merupakan tanda bahaya	B	S
2	Ibu nifas yang muka, tangan dan kaki bengkak merupakan tanda bahaya nifas	B	S
3	Pandangan kabur pada ibu nifas merupakan tanda bahaya ibu nifas	B	S
4	Mengeluarkan cairan yang berbau merupakan tanda bahaya nifas	B	S
5	Sakit kepala hebat merupakan tanda bahaya nifas	B	S
6	Nyeri perut hebat merupakan tanda bahaya kehamilan	B	S
7	Nyeri pada payudara yang hebat merupakan tanda bahaya nifas	B	S
8	Sedih murung pada ibu nifas merupakan tanda bahaya nifas	B	S

9	Hilangnya Nafsu makan merupakan tanda bahaya nifas	B	S
10	Rasa tidak suka dan tidak mau merawat bayi merupakan tanda bahaya nifas	B	S

No	Pertanyaan ASI eksklusif	Jawaban	
1	ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan selama 6 bulan tanpa makanan tambahan pada bayi	B	S
2	Bayi umur 5 bulan dengan makanan tambahan buah jeruk merupakan ASI eksklusif	B	S
3	Bayi umur 5 bulan dengan makanan tambahan bubur sumsum merupakan ASI eksklusif	B	S
4	Bayi dalam sehari menyusu kurang lebih 10 sampai 12 kali	B	S
5	Bayi sering buang air kecil lebih dari 6 kali adalah tanda cukup ASI	B	S
6	Bayi yang minum ASI saja saat tidur selalu nyenyak adalah tanda bayi kenyang cukup ASI	B	S
7	ASI eksklusif membuat bayi sehat	B	S
8	Memberikan ASI eksklusif termasuk penghematan Negara	B	S
9	ASI lebih mudah dan murah didapatkan	B	S
10	Berat badan bayi pada bulan pertama bertambah 900 gr adalah tanda cukup ASI/ASI eksklusif	B	S

BIOGRAFI PENULIS



UMAROH, S.KM., M.Kes. Lahir di Jepara pada tanggal 14 Maret 1969; Telah menyelesaikan Pendidikan Kesarjanaannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat di FKM UNDIP pada tahun 2003; dan Sarjana Terapan Kebidanan pada tahun 2016 di Poltekkes Kemenkes Semarang; serta pendidikan Magister dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak di MIKM UNDIP tahun 2011. Sejak Tahun 1998 sampai sekarang, telah menjadi dosen di Prodi D III

Kebidanan Semarang, Jurusan kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang yang beralamat di Jl. Tirtoagung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp. (024) 76479186/(024) 76479187; dengan Jabatan Fungsional terakhir Lektor. Korespondensi dapat dilakukan dengan melalui Nomor WA: 08122814651; Surel: umazaini@gmail.com.



ULFAH MUSDALIFAH, S.Kep., Ns., S.Tr.Keb., M.Kes. Lahir di Jepara pada tanggal 10 Maret 1968, berhasil menyelesaikan Pendidikan Kesarjanaannya dalam bidang Keperawatan dan Pendidikan Profesi di FIK UI tahun 2001 dan Sarjana Terapan Kebidanan di Prodi Prodi D IV Magelang Poltekkes Kemenkes Semarang, pada tahun 2017; serta berhasil menyelesaikan pendidikan Magister dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak di MIKM UNDIP tahun 2013.

Sejak Tahun 1998 sampai sekarang, telah menjadi dosen di Prodi D III Kebidanan Semarang, Jurusan kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang yang beralamat di Jl. Tirtoagung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp. (024) 76479186/(024) 76479187; dengan Jabatan Fungsional terakhir Lektor. Korespondensi dapat dilakukan dengan melalui Nomor WA: 085225068921; atau dengan Surel: ulfah_musdalifah@yahoo.com.



DHITA AULIA OCTAVIANI, S.ST., M.Keb. Lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 22 Oktober 1986, telah berhasil menyelesaikan Pendidikan Kesarjanaannya dalam bidang Kebidanan di Prodi D IV Kebidanan Poltekkes Depkes Semarang pada tahun 2008; dan pendidikan Magister dalam bidang Kebidanan di Universitas Padjajaran pada tahun 2017. Sejak 1 April 2019 sampai sekarang, menjadi dosen di Prodi D III Kebidanan Semarang, Jurusan

Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang, yang beralamat kantor di Jl. Tirtoagung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp. (024) 76479186/(024) 76479187; dengan Jabatan Asisten Ahli. Korespondensi dapat dilakukan dengan melalui No. WA: 081325061986; Surel: dhitaaulia@poltekkes-smg.ac.id.

Diterbitkan oleh :

Polteknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Telp. 0247477208; Surel: perpustakaanpoltekkessmg@yahoo.com

Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Ke. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah (50268)



ISBN 978-623-6730-45-4

